OFFRE DE SOINS ET SYSTÈME DE SANTÉ

UE C1.1 · SEMESTRE 1 · FICHE DE RÉVISION

Séance du 26 octobre 2026 · Université Paris-Saclay

Comprendre qui intervient, où les soins sont réalisés et comment les décisions, les parcours et les financements s'articulent. Les schémas simplifient les liens ; les explications conservent les distinctions utiles.

Système et professionnels · p. 1
Lieux et modalités · p. 3
Niveaux de recours · p. 5
Parcours et coordination · p. 6
Pilotage et histoire · p. 8
Expertise et qualité · p. 11
Financement · p. 11
Surveillance et recherche · p. 13
Pièges et synthèse · p. 15
Définitions · p. 16

01 · Du système de santé au système de soins

La santé publique s'intéresse à l'état de santé des populations et aux actions collectives qui permettent de le préserver ou de l'améliorer. La santé ne se réduit pas à l'absence de maladie : elle comporte des dimensions physique, mentale et sociale. Les besoins ne sont donc pas uniquement des besoins de consultations, d'examens ou de traitements.

Le système de santé est l'ensemble organisé des acteurs, des institutions, des ressources et des activités qui concourent à la santé. Le système de soins en constitue une partie : il répond à des besoins de santé par des interventions préventives, curatives, de réadaptation ou palliatives. La prévention existe aussi en dehors de la rencontre individuelle avec un soignant, par exemple dans les politiques publiques ou les actions collectives.

Un système de santé dépasse les seuls soins

Gouvernance et pilotage
Orientations, règles et organisation

Système de soins
Professionnels, structures et interventions

Médicaments
Organisation de leur mise à disposition

Prévention et promotion
Actions sur la santé et ses conditions

Financement
Ressources et prise en charge des dépenses

Information, surveillance et recherche
Connaissances, détection des risques, innovation

Ces composantes coopèrent. Les blocs ne représentent ni une chaîne chronologique ni une hiérarchie entre institutions.

Objectif	Ce qu'il implique
Préserver ou améliorer la santé	Prévenir les maladies et leurs conséquences ; réduire la mortalité prématurée et favoriser une vie en bonne santé.
Répondre aux attentes de la population	Associer accès, qualité, sécurité et continuité : une succession de consultations isolées ne suffit pas.
Assurer l'équité	Permettre des réponses adaptées aux besoins, sans discrimination. Une offre identique en apparence ne garantit pas un accès effectif identique.

À retenir

Système de santé ≠ système de soins. Soigner, financer, prévenir, organiser et surveiller sont des fonctions différentes, mais interdépendantes.

02 · Professions, ordres et modes d'exercice

Les professionnels de santé ne forment pas un groupe homogène. Le cours distingue trois ensembles. Cette classification décrit des professions ; elle ne permet pas de déduire à elle seule tous les actes qu'un professionnel peut réaliser ni l'étendue de ses responsabilités.

Ensemble	Professions et repères
Professions médicales	Médecins, chirurgiens-dentistes ou odontologistes, sages-femmes. La maïeutique renvoie à la profession de sage-femme.
Pharmacie et physique médicale	Pharmaciens d'officine, hospitaliers ou biologistes ; physiciens médicaux. Les fonctions et lieux d'exercice sont différents.
Auxiliaires médicaux	Notamment infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes, orthoptistes, ergothérapeutes et autres professions de cet ensemble. Il ne s'agit pas d'une liste d'actes autorisés.

Le rôle des ordres professionnels

Les sept ordres présentés concernent les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues. Ils contribuent à la régulation de l'exercice, au suivi du tableau de leur profession, à la déontologie et à la discipline. Ils participent aussi à la représentation de la profession et au suivi du développement professionnel. Un ordre n'est ni un employeur ni un organisme de remboursement.

Mode d'exercice	Logique à distinguer
Salarié	Le professionnel exerce dans le cadre d'un emploi et perçoit un salaire. Le salaire individuel ne se confond pas avec le mode de financement de la structure.
Libéral	Le professionnel exerce de manière indépendante ; la rémunération à l'acte est le modèle principalement utilisé dans les exemples du cours.
Mixte	Une même personne peut combiner activité salariée et activité libérale. Le lieu de travail ne suffit donc pas à identifier son statut.

Une distinction utile

« Paramédical » ne signifie pas absence de compétences propres. Les droits de prescription ou d'accès direct ne se déduisent pas d'une opposition simplifiée entre médical et paramédical.

03 · Répartition de l'offre et accès effectif

L'offre de soins désigne les professionnels, structures, équipements et services mobilisables pour répondre aux besoins. Sa répartition varie selon les territoires et les spécialités. Une carte des effectifs ou de la densité décrit une dimension de l'offre ; elle ne démontre pas, à elle seule, qu'une personne obtient effectivement le rendez-vous ou le soin dont elle a besoin.

Indicateur	Comment le lire
Effectif	Nombre de professionnels dans un périmètre donné. Il dépend notamment de la taille de la population du territoire.
Densité	Nombre de professionnels rapporté à une population, selon l'unité indiquée. Comparer des densités exige un même champ et une même unité.
Évolution observée	Données recueillies à plusieurs dates. Une variation de médecins généralistes ne décrit pas automatiquement celle de tous les médecins.
Projection	Scénario sur l'avenir, fondé sur des hypothèses. Une projection pour 2050 n'est pas un effectif déjà observé.

Les documents présentés montrent des disparités géographiques et une évolution de la démographie professionnelle. La courbe des généralistes ne doit pas être lue comme une hausse continue depuis 2010 : elle comporte une baisse puis une remontée. Pour interpréter un chiffre, préciser la date, le territoire, la profession et le type de mesure.

Application au raisonnement infirmier

Un territoire peut disposer de professionnels tout en présentant des obstacles d'accès : délais, déplacements, disponibilité, coordination ou compréhension des démarches. Décrire l'offre disponible puis les difficultés concrètes évite de confondre présence théorique et recours effectif.

04 · Trois grands lieux de soins

Les professionnels exercent dans des établissements de santé, des structures médico-sociales et en ville. Ces catégories décrivent des lieux et des organisations ; elles ne sont pas des niveaux de gravité. Le parcours d'une même personne peut les relier successivement ou simultanément.

Lieu	Finalité et exemples
Établissement de santé	Diagnostic, surveillance et traitement ; soins avec ou sans hébergement, y compris à domicile dans certaines organisations. L'établissement participe à la coordination avec la ville et le médico-social.
Structure médico-sociale	Associer soins, autonomie, besoins sociaux et projet de vie. Exemples : EHPAD, structures pour personnes en situation de handicap, services d'accompagnement. Comprendre leur finalité compte davantage que réciter toutes leurs appellations.

Lieu	Finalité et exemples
Ville	Consultations et soins hors établissements de santé et structures médico-sociales : cabinets, centres de santé, pharmacies d'officine, interventions de professionnels à domicile.

Public, privé non lucratif et privé lucratif

Les établissements publics comprennent notamment les centres hospitaliers, les CHR ou CHU, les hôpitaux de proximité et des établissements spécialisés. Parmi les établissements privés, distinguer le but non lucratif, dont les ESPIC, et le but lucratif, souvent désigné par le terme clinique. Ce statut juridique ne décrit pas, à lui seul, toutes les activités, autorisations ou missions de l'établissement.

Type de prise en charge	Repère
MCO	Médecine, chirurgie, obstétrique : prise en charge de situations nécessitant ces activités.
Réadaptation	Récupération et adaptation après une maladie ou une intervention. Le support emploie l'appellation SSR pour ce secteur.
USLD	Surveillance médicale importante et durable, pour des personnes dont l'état la nécessite.
Établissement ou équipe spécialisée	Exemples du cours : psychiatrie, cancérologie. La spécialisation ne se déduit pas du seul statut public ou privé.

À retenir

Un EHPAD ne devient pas un hôpital parce que des soins y sont réalisés. Le médico-social articule le soin avec l'accompagnement de l'autonomie et de la vie quotidienne.

05 · Hospitalisation, ambulatoire et domicile

La distinction centrale porte sur le mode de prise en charge, et non seulement sur l'adresse du soin. Des soins ambulatoires peuvent être réalisés à l'hôpital ; inversement, une hospitalisation peut être organisée au domicile.

Modalité	Caractéristique
Hospitalisation conventionnelle	Séjour comportant un hébergement et des nuitées dans l'établissement.
Hôpital de semaine	Organisation de séjours hospitaliers sur la semaine.
Hôpital de jour	Venue pour des examens ou un traitement, pendant quelques heures ou la journée, sans nuitée.
Consultation ou examen hospitalier	Activité à l'hôpital sans hébergement ; le lieu hospitalier ne suffit pas à parler d'hospitalisation complète.
Soins de ville	Consultations, prélèvements, soins au cabinet ou à domicile, selon l'activité.
HAD	Hospitalisation à domicile : organisation hospitalière au domicile. Toute intervention d'un infirmier à domicile n'est pas une HAD.

Le virage ambulatoire correspond au développement de prises en charge sans séjour avec nuitée lorsque la situation s'y prête. Il peut limiter certains séjours et faciliter le retour dans le milieu de vie. Il suppose cependant une organisation adaptée : état de la personne, conditions au domicile, entourage, relais professionnels et possibilité de suivi. La sortie ne termine pas le parcours.

Exemple : préparer une sortie

Avant le retour à domicile d'une personne âgée, identifier les soins prévus, les professionnels relais, les informations à transmettre et les difficultés possibles. Organiser cette continuité est aussi important que programmer la sortie administrative.

06 · Soins programmés, non programmés et urgences

Situation	Logique d'organisation
Soins programmés	Consultation de suivi ou intervention anticipée, planifiée en fonction du besoin et des ressources disponibles.
Soins non programmés	Besoin d'une réponse rapide qui ne peut pas attendre la programmation habituelle, sans être assimilé automatiquement à une urgence vitale.
Urgence vitale	Situation nécessitant une réponse immédiate et une orientation adaptée ; elle ne relève pas d'une simple attente de rendez-vous.

Pour un besoin non programmé, le médecin traitant peut être un interlocuteur. Lorsqu'il n'est pas disponible ou lorsque la personne n'en a pas, le service d'accès aux soins (SAS) participe à la régulation et à l'orientation. Le dispositif présenté met en relation la demande avec des ressources du territoire, afin d'apporter une réponse adaptée et d'éviter des passages aux urgences qui pourraient être pris en charge autrement.

La régulation sert à évaluer la demande et à orienter : elle ne correspond pas à l'attribution automatique d'un rendez-vous. Le délai évoqué en cours illustre l'objectif de réponse rapide ; il ne constitue pas une garantie valable pour toute personne et toute situation.

À retenir

« Non programmé » décrit le caractère imprévu du besoin ; « urgent » décrit son degré de priorité. Ces deux dimensions ne sont pas interchangeables.

07 · Les niveaux de recours

Les niveaux de recours décrivent la complexité et les ressources nécessaires à la prise en charge. Ils ne constituent pas une simple échelle de bâtiments, de prestige ou de localisation. Une consultation spécialisée de deuxième recours peut avoir lieu en ville ; un CHU réalise aussi des soins qui ne sont pas de haute spécialisation.

Niveau	Fonction et exemple
Primaire : premier recours	Premier contact, réponse aux besoins courants, prévention et suivi au plus près de la population. Mobilise notamment généralistes, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, dentistes et kinésithérapeutes.
Secondaire : recours spécialisé	Expertise spécialisée lorsque les ressources habituelles du premier recours ne suffisent pas : cardiologue en ville, consultation ou hospitalisation spécialisée. Le schéma du cours y inclut les urgences hospitalières.

Niveau	Fonction et exemple
Tertiaire	Prises en charge complexes nécessitant équipes, organisation et équipements spécialisés : chirurgie complexe, centre expert de maladie rare, certains traitements anticancéreux.
Quaternaire	Prises en charge particulièrement spécialisées ou inhabituelles, dont des procédures expérimentales dans le cadre présenté. Ce n'est pas une étape obligatoire de tout parcours.

Lire la hiérarchisation

Le premier recours est la base de l'accès aux soins, pas un soin de moindre valeur. L'orientation vers un niveau spécialisé répond à un besoin de moyens ou d'expertise.

08 · Le parcours de soins coordonné

Un parcours de soins coordonné organise l'enchaînement des consultations, examens, traitements et suivis d'une personne. Son objectif est la cohérence des décisions et la continuité, au-delà d'un rendez-vous isolé. Le médecin traitant joue un rôle central : soins et prévention personnalisée, orientation, coordination et suivi.

Le médecin traitant peut être généraliste ou spécialiste, en ville ou à l'hôpital. Sa fonction ne se résume pas à rédiger un adressage. Après une consultation spécialisée ou un séjour, les informations utiles doivent permettre de reprendre le suivi et d'articuler les interventions.

Orientation et retour d'information

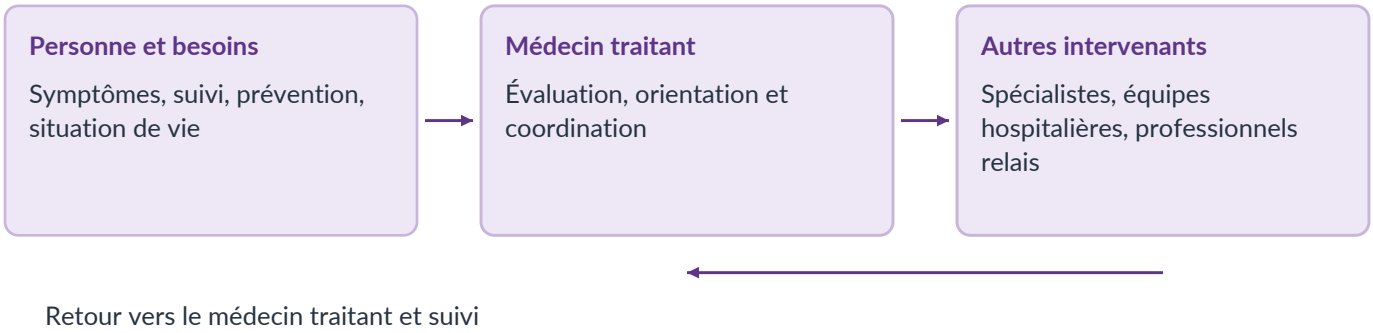


Schéma de principe : orientation vers les ressources adaptées, puis retour d'information et suivi. Il ne représente ni toutes les exceptions ni la conduite à tenir en urgence.

Le parcours coordonné a aussi une dimension de prise en charge financière. Des situations d'accès direct ou particulières existent. Il faut distinguer ce principe organisationnel des règles précises de remboursement, qui dépendent du cadre applicable : une spécialité, un âge, une urgence ou un suivi ne se résument pas à un taux unique.

Exemple : une orientation n'est pas une fin

Un patient reçoit un avis spécialisé, puis revient vers son médecin traitant. Le compte rendu permet de comprendre la décision, d'ajuster le suivi et de relier les autres professionnels. Sans ce retour, les soins peuvent se juxtaposer sans réelle continuité.

09 · Le parcours de santé : un périmètre plus large

Le parcours de santé englobe le parcours de soins et les dimensions médico-sociales et sociales. Il ne suit donc pas seulement une maladie ou une suite d'actes : il prend en compte les besoins de la personne dans son milieu de vie, notamment l'autonomie, les ressources, les déplacements et l'accès aux droits.

Trois dimensions à articuler

Parcours de santé

Parcours de soins
Consultations, examens, traitements, suivi

Médico-social
Autonomie, accompagnement, lieu de vie

Social
Droits, logement, mobilité, vie quotidienne

Le parcours de santé englobe ces trois dimensions. Les blocs désignent des domaines à articuler, pas trois étapes successives.

Application : retour à domicile d'une personne âgée

Prévoir un pansement ou un rendez-vous relève du parcours de soins. Évaluer l'aide pour la toilette, l'alimentation, les déplacements et l'accès aux droits élargit le raisonnement au parcours de santé. La réponse associe plusieurs acteurs, avec l'accord et la participation de la personne.

L'oral insiste sur la continuité ville-hôpital : repérer une difficulté au domicile, la transmettre au médecin ou à l'équipe concernée et adapter l'organisation. Une coordination lors d'une période de chaleur illustre également l'intérêt de relier besoins des habitants, surveillance et ressources locales ; ce n'est pas un protocole unique à appliquer à tous.

10 · L'exercice coordonné en ville

L'exercice coordonné vise à organiser le travail entre professionnels autour d'une population, d'un projet ou d'un territoire. Il répond notamment à la fragmentation des prises en charge. Travailler à proximité n'assure pas automatiquement cette coordination : il faut des objectifs, des liens et des modalités de coopération.

Organisation	Repère distinctif
ESP : équipe de soins primaires	Professionnels du premier recours qui coordonnent leurs pratiques autour d'une population ou d'un projet. Ils peuvent continuer d'exercer dans leurs cabinets respectifs.
CDS : centre de santé	Structure réunissant des professionnels et des activités de soins, avec des professionnels généralement salariés dans la présentation du cours.
MSP : maison de santé pluriprofessionnelle	Organisation pluriprofessionnelle de soins avec un projet commun ; les professionnels sont généralement libéraux dans les exemples présentés.
CPTS : communauté professionnelle territoriale de santé	Coordination à l'échelle d'un territoire, entre professionnels de ville, établissements et médico-social. Elle ne se réduit pas à un lieu où consulter.

Les missions d'une CPTS

Axe	Exemple de contribution
Accès aux soins	Faciliter l'accès à un médecin traitant et organiser des réponses aux besoins du territoire.
Parcours complexes	Renforcer les liens entre ville, hôpital et médico-social.
Prévention	Mettre en œuvre des actions répondant aux besoins de la population.
Crises sanitaires	Contribuer à une réponse coordonnée en situation de crise.
Accompagnement des professionnels	Soutenir l'installation et les coopérations.
Qualité et pertinence	Améliorer l'organisation des soins et leur adéquation aux besoins.

À retenir

Une MSP et une CPTS ne sont pas synonymes. La première est une organisation de soins pluriprofessionnelle ; la seconde agit sur la coordination territoriale, au-delà d'une seule structure.

11 · Les outils numériques au service de la continuité

Le dossier médical partagé (DMP) et Mon espace santé sont présentés comme des moyens de faciliter la circulation des informations utiles au parcours. L'enjeu est de rendre disponibles les éléments nécessaires au suivi et de limiter les ruptures d'information entre intervenants.

Une messagerie sécurisée protège le canal d'échange ; elle ne transforme pas tout document en information à transmettre à tout destinataire. Il reste nécessaire de s'interroger sur le destinataire, l'utilité de l'information pour la prise en charge et le cadre de confidentialité. L'outil numérique soutient la coordination : il ne remplace ni le raisonnement professionnel ni le dialogue avec la personne.

Application

Avant de transmettre un compte rendu, vérifier à qui il est destiné et en quoi il contribue au suivi. Un document techniquement accessible n'est pas, pour cette seule raison, à diffuser sans limite.

12 · Pilotage national et adaptation territoriale

Le pilotage définit des orientations, des règles et des moyens pour répondre aux besoins de santé. L'échelon national et l'échelon régional n'ont pas le même rôle. La politique nationale donne un cadre ; sa mise en œuvre doit tenir compte des besoins et ressources des territoires.

Acteur ou niveau	Fonction à distinguer
Parlement	Assemblée nationale et Sénat : vote des lois, dont la loi de financement de la Sécurité sociale.
Ministère chargé de la santé	Élaboration et conduite des politiques nationales ; mobilisation des directions compétentes.
ARS : échelon régional	Mise en œuvre et adaptation de la politique de santé dans la région, avec des missions d'organisation, de prévention et de sécurité sanitaire.

Acteur ou niveau	Fonction à distinguer
Acteurs du territoire	Professionnels, établissements et organisations coordonnent les réponses concrètes aux besoins.

Le cours utilise la déconcentration pour décrire le déploiement territorial d'un pilotage national. La décentralisation renvoie à une autre logique de répartition des compétences. L'idée à retenir est la distinction entre cadre national et mise en œuvre territoriale, sans réduire toute l'organisation de la santé à une seule chaîne hiérarchique.

> **Un exemple donné à l'oral**
>
> Une région peut avoir des besoins particuliers de prévention, d'accès aux soins ou de réponse à une crise. L'ARS ne se contente pas d'une copie uniforme : elle doit articuler les orientations avec la situation du territoire.

13 · Repères historiques : comprendre les évolutions

Les repères historiques permettent de comprendre comment le système s'est construit. L'intervenante souligne l'importance de reconnaître les périodes et les grands apports ; cela ne constitue pas une annonce selon laquelle toutes les dates exactes seraient à réciter à l'examen.

Repère	Apport à relier au système actuel
1902 : premières grandes lois sanitaires	Développement d'une organisation collective de l'hygiène et de la lutte contre les menaces sanitaires.
1945 : Sécurité sociale	Construction d'une protection sociale collective. Ce repère historique ne décrit pas à lui seul l'architecture actuelle de toutes les branches.
1958 : réforme hospitalo-universitaire	Création des CHU et articulation de trois missions : soin, enseignement et recherche.
2002 : droits des patients	Renforcement de la place et des droits de la personne soignée.
2009 : loi HPST	Repère d'organisation territoriale, notamment les ARS et les ESPIC.
2016 : modernisation du système de santé	Repère pour les coopérations, le numérique, la prévention et l'évolution des pratiques professionnelles.
2019 : transformation du système	Réforme de l'accès aux études médicales, développement des assistants médicaux et du numérique.
2023 : accès aux soins et compétences	Repère d'élargissement de certaines compétences et d'accès aux soins sous conditions. Ne pas en déduire une autorisation générale pour tout acte.

Les lois de santé et la LFSS n'ont pas le même objet. La LFSS est votée annuellement et fixe notamment des objectifs financiers. La référence du support à des lois de santé « quinquennales » ne signifie pas qu'une loi générale de santé est automatiquement votée tous les cinq ans.

14 · Les grandes directions et les ARS

Les directions du ministère se distinguent par leur champ d'action. Pour identifier le bon acteur, partir de la fonction : politique de santé publique, organisation des soins, protection sociale, cohésion sociale ou production de connaissances.

Sigle	Fonction principale
DGS	Direction générale de la santé : objectifs et politiques de santé publique, protection de la population face aux menaces sanitaires.
DGOS	Direction générale de l'offre de soins : pilotage stratégique de l'offre, adéquation aux besoins et attention à la qualité, à la sécurité et à la place des usagers.
DSS	Direction de la Sécurité sociale : cadre de la protection sociale, préparation des mesures et des objectifs de dépenses, suivi de l'équilibre financier.
DGCS	Direction générale de la cohésion sociale : lutte contre l'exclusion, familles, autonomie, égalité et métiers du social ou du médico-social.
DREES	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques : analyses et informations fiables sur les sujets sanitaires et sociaux.
IGAS	Inspection générale des affaires sociales : corps d'inspection cité dans l'organisation présentée.

Les quatre domaines d'action des ARS

Les ARS interviennent dans l'organisation de l'offre de soins, l'organisation de l'accompagnement médico-social, la prévention et la promotion de la santé, ainsi que la veille et la sécurité sanitaire. Elles participent notamment à la surveillance des risques et à la coordination des réponses aux crises dans leur région.

> **À retenir**
>
> DGS, DGOS et DSS ne sont pas interchangeables : santé publique, offre de soins et Sécurité sociale sont trois fonctions distinctes. DREES renvoie aux études et statistiques, même si un titre de diapositive comporte une coquille.

15 · Les acteurs internationaux et européens

Les politiques françaises s'inscrivent dans un environnement international. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) intervient à l'échelle mondiale ; l'UNICEF est un acteur international associé notamment aux enjeux de l'enfance. À l'échelle européenne, des institutions et agences contribuent aux politiques, à la surveillance et à l'expertise en santé.

Le cours illustre l'influence européenne par les avertissements sanitaires sur les produits du tabac et par la protection des données personnelles, dont les données de santé. Ces exemples servent à comprendre que certaines règles ne se construisent pas uniquement à l'échelon national.

> **Lire les exemples sans les confondre**
>
> Une directive et un règlement européen ne sont pas deux noms pour un même instrument. Les diapositives rapprochent des exemples d'influence européenne ; elles ne permettent pas d'appliquer une procédure unique de transposition à tous les textes.

Pour la révision de ce cours, l'objectif est de reconnaître l'échelle mondiale, européenne, nationale ou régionale et la fonction de l'acteur. Il n'est pas nécessaire de transformer les schémas illustratifs en une description exhaustive de la hiérarchie des normes.

16 · Expertise, HAS et évaluation des soins

Les organismes sanitaires produisent des connaissances, des avis ou des actions spécialisées qui éclairent les décisions. Leurs missions diffèrent. La Haute Autorité de santé (HAS) est un organisme d'expertise scientifique indépendant : elle ne se confond ni avec le ministère ni avec un organisme de remboursement.

La HAS intervient notamment dans l'évaluation des produits et actes de santé, la certification des établissements, l'élaboration de recommandations de bonne pratique et l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L'existence d'une recommandation ne signifie pas que tous les patients reçoivent mécaniquement le même acte : la situation et les besoins restent à analyser.

Notion	Question à se poser
Qualité	Le soin est-il réalisé correctement et dans de bonnes conditions ?
Pertinence	Ce soin est-il utile et adapté au besoin de cette personne ?
Efficience	Comment mettre en relation les résultats obtenus et les ressources mobilisées ? L'analyse ne se réduit pas au prix le plus bas.

Exemple de l'intervenante

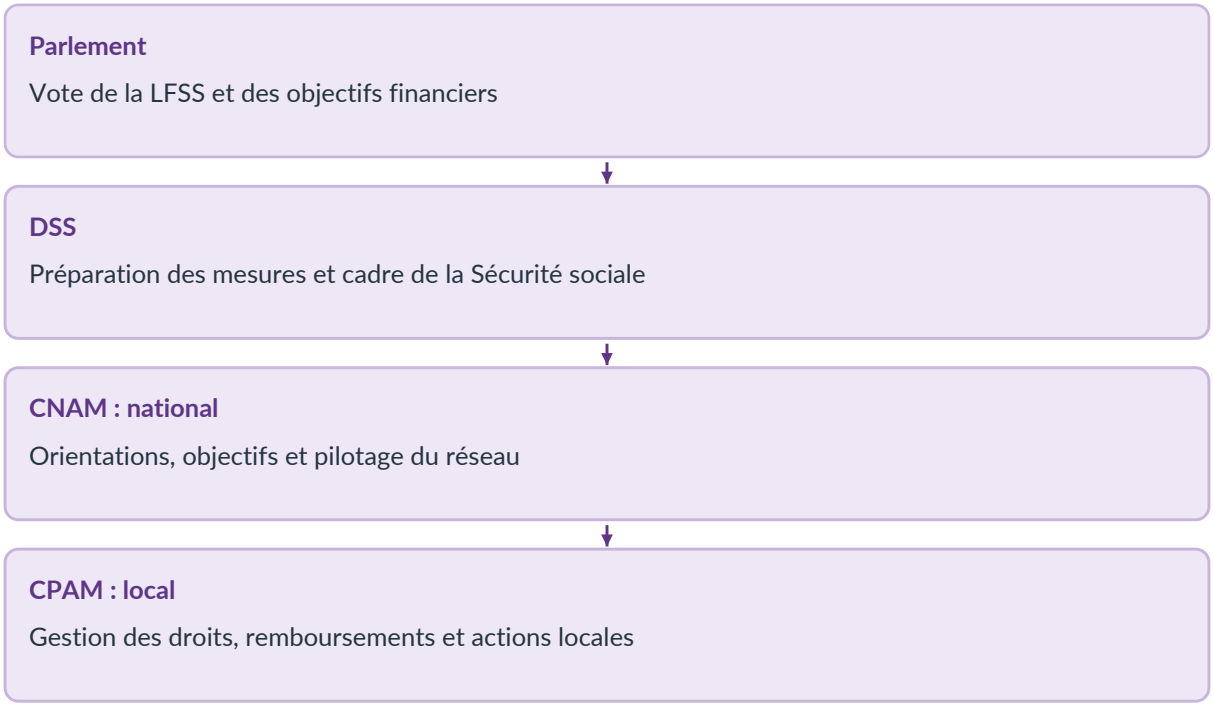
Une prise de sang peut être techniquement bien réalisée tout en étant inutile dans la situation. La qualité de réalisation et la pertinence de l'indication sont deux jugements différents. Répéter un acte sans bénéfice attendu mobilise aussi des ressources.

17 · Le financement : distinguer les fonctions

La Sécurité sociale protège contre différents risques de la vie. L'Assurance maladie en est une composante, pas un synonyme de l'ensemble. Cette partie du cours présente les principaux acteurs ; l'économie de la santé développe plus largement les mécanismes de financement.

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) et l'objectif national de dépenses d'Assurance maladie (ONDAM) donnent un cadre et des objectifs financiers. L'ONDAM n'est ni un organisme qui rembourse un patient ni le montant du salaire d'un soignant.

Du cadre national à la mise en œuvre locale



Repérage des fonctions dans le schéma du cours : il ne s'agit pas d'un calendrier exhaustif de préparation et de vote de la loi.

Organisme	Rôle à comprendre
CNAM	Caisse nationale de l'Assurance maladie : orientations nationales, pilotage du réseau, objectifs, négociations avec les représentants des professionnels et actions nationales de prévention.
CPAM	Caisse primaire d'Assurance maladie : accompagnement des assurés et gestion des droits, remboursements pris en charge, indemnités journalières et actions locales de prévention ou de lutte contre le non-recours.

La maîtrise médicalisée des dépenses recherche des gains d'efficience dans une logique médicale. Elle ne signifie pas que toute réduction de dépense est, à elle seule, une amélioration du soin. Préserver la pertinence, la qualité et la sécurité fait partie du raisonnement.

> **À retenir**
>
> CNAM = échelon national ; CPAM = mise en œuvre locale. Ne pas confondre une direction du ministère, une caisse nationale et une caisse locale.

18 · Assurance maladie, complémentaire et reste à charge

Le reste à charge correspond à la part d'une dépense qui demeure après la prise en charge considérée. Il faut préciser de quelle prise en charge on parle : la part qui reste après l'Assurance maladie n'est pas nécessairement la somme finalement payée après l'intervention d'une complémentaire.

La complémentaire santé peut prendre en charge tout ou partie de ce qui n'est pas couvert par l'Assurance maladie, dans les conditions de la couverture concernée. Une mutuelle est un type d'organisme pouvant proposer une complémentaire ; toutes les complémentaires ne sont pas des mutuelles.

À distinguer	Conséquence pour la compréhension
Assurance maladie / complémentaire	Deux niveaux de prise en charge qui ne sont pas interchangeables.
Couverture / organisme	La complémentaire désigne une couverture ; la mutuelle désigne une catégorie d'organisme.
Remboursement / avance des frais	Le fait de ne pas avancer une somme ne prouve pas, à lui seul, une couverture intégrale de toute dépense.
Exemple chiffré / règle applicable	Un calcul simplifié présenté oralement ne suffit pas à déterminer un remboursement réel.

Application

Lorsqu'un coût constitue un obstacle, repérer la difficulté, vérifier les interlocuteurs compétents et faciliter l'orientation. Ne pas promettre un taux, une somme ou une gratuité à partir d'un exemple général.

19 · Surveillance sanitaire et vigilances

La surveillance sanitaire consiste à recueillir et analyser des informations pour suivre l'état de santé, l'évolution des maladies et les risques. Elle aide à repérer des signaux, à alerter et à organiser une réponse. Elle s'articule avec la prévention et la gestion des crises.

Échelle ou acteur	Repère de mission
OMS / ECDC	Échelle mondiale / échelle européenne. L'ECDC participe à la surveillance des maladies et épidémies et aux recommandations de prévention.
Santé publique France	Agence nationale de santé publique : observation, surveillance, prévention, promotion de la santé et réponse aux menaces sanitaires.
ANSES	Expertise en sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ; articulation avec des enjeux de santé animale et végétale.
ARS	Surveillance et coordination des réponses au niveau régional.

La sécurité des produits de santé

Terme ou acteur	Champ à identifier
Pharmacovigilance	Surveillance des effets et risques liés aux médicaments.
Matériovigilance	Surveillance des risques liés aux dispositifs médicaux.
Hémovigilance	Surveillance de la chaîne transfusionnelle et des produits sanguins concernés.
Biovigilance	Surveillance des activités et produits biologiques concernés, notamment dans le domaine des greffes.
ANSM / EMA	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé / Agence européenne des médicaments. Distinguer les échelles et leurs missions propres.
EFS	Établissement français du sang : collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins labiles.
Agence de la biomédecine	Acteur de référence pour les greffes et d'autres domaines biologiques et médicaux présentés dans le cours.

L'oral explique qu'un effet rare peut être repéré après la mise à disposition d'un médicament. Cela donne du sens à la surveillance et au signalement : une utilisation ancienne ne démontre pas l'absence de tout risque. La surveillance complète l'évaluation initiale ; elle ne sert pas seulement à compter des événements.

20 · Recherche et raisonnement d'ensemble

La recherche et l'innovation en santé mobilisent notamment les CHU et universités, les organismes ou instituts de recherche et les laboratoires pharmaceutiques. Retenir ces grandes familles est plus utile que mémoriser chaque logo cité. Dans un CHU, soin, enseignement et recherche sont trois missions articulées, mais elles ne sont pas trois actes identiques.

Relier les acteurs à une situation

Besoin observé	Fonctions à mobiliser dans le raisonnement
Un patient sort de l'hôpital	Relais de ville, coordination du parcours, informations utiles, besoins médico-sociaux et sociaux.
Une difficulté d'accès concerne plusieurs habitants	Répartition de l'offre, exercice coordonné, CPTS et organisation territoriale.
Un problème de qualité ou d'indication est identifié	Qualité, pertinence, expertise et recommandations ; distinguer le rôle des professionnels de celui des institutions.
Un risque sanitaire émerge	Recueil et analyse d'informations, surveillance, alerte et coordination de la réponse.
Une question de prise en charge financière se pose	Cadre de financement, Assurance maladie, complémentaire et interlocuteurs adaptés ; ne pas confondre les organismes.

Méthode de révision

Pour chaque acteur, savoir répondre : à quelle échelle intervient-il, quelle fonction remplit-il et avec qui s'articule-t-il ? Les exemples d'examen évoqués à l'oral servent à s'entraîner au raisonnement ; ils ne garantissent pas le contenu d'une future épreuve.

21 · Pièges QCM et confusions à éviter

Confusion	Distinction à retenir
Santé = soins	Le système de santé englobe aussi pilotage, prévention, financement, information et surveillance.
Densité = effectif = accès	Ce sont trois dimensions différentes.
Tout soin à l'hôpital comporte une nuitée	L'hôpital assure aussi des consultations, examens et prises en charge ambulatoires.
Tout soin à domicile est une HAD	L'HAD est une organisation hospitalière spécifique.
Médico-social = hospitalisation	Le médico-social associe soins et accompagnement de la vie et de l'autonomie.
Second recours = hôpital ; premier recours = ville	Le niveau décrit les ressources et l'expertise ; le deuxième recours existe aussi en ville.
Le médecin traitant est toujours généraliste	Il peut être généraliste ou spécialiste, y compris hospitalier.
Parcours de soins = parcours de santé	Le parcours de santé englobe aussi les dimensions médico-sociales et sociales.
CPTS = MSP	Coordination territoriale et organisation pluriprofessionnelle de soins ne sont pas synonymes.
Canal sécurisé = partage illimité	Sécurisation technique, destinataire, utilité et confidentialité sont des questions différentes.
DGS = DGOS = DSS	Santé publique, offre de soins et Sécurité sociale sont des champs distincts.
CNAM = CPAM	Échelon national et mise en œuvre locale.
Assurance maladie = Sécurité sociale	L'Assurance maladie est une composante du système de protection sociale.
Mutuelle = toute complémentaire	Une mutuelle est un type d'organisme proposant une couverture complémentaire.
Bonne technique = acte forcément utile	Qualité et pertinence ne se confondent pas.
Efficience = soin le moins cher	Mettre en relation les résultats et les ressources, en préservant la qualité et la sécurité.
Projection = observation	Une projection repose sur des hypothèses et concerne une période future.

22 · Synthèse générale - L'essentiel du cours

Le système de santé associe plusieurs fonctions pour améliorer la santé de la population, répondre aux attentes et assurer l'équité. Le système de soins en est une composante. Ses professionnels exercent en établissement de santé, dans le médico-social ou en ville, sous des statuts variés.

Le lieu, le mode de prise en charge, le niveau de recours et le degré d'urgence sont quatre axes différents. L'ambulatoire peut être hospitalier ; l'HAD est une hospitalisation au domicile. Les niveaux de recours se distinguent par les moyens et compétences nécessaires.

Le parcours coordonné relie les interventions autour du patient, avec un rôle central du médecin traitant et un retour d'information. Le parcours de santé élargit cette logique aux besoins médico-sociaux et sociaux. ESP, CDS, MSP et CPTS soutiennent des formes distinctes de coopération ; les outils numériques peuvent faciliter la continuité.

Parlement, ministère et ARS n'interviennent pas à la même échelle ni sur les mêmes fonctions. DGS, DGOS, DSS, DGCS et DREES ont des domaines propres. Les agences et la HAS apportent des expertises et actions distinctes ; la HAS contribue notamment à la qualité, à la sécurité et à la pertinence.

Le financement articule cadre national, Assurance maladie et couverture complémentaire. CNAM et CPAM correspondent aux échelons national et local. La surveillance sanitaire et les vigilances aident à détecter les risques, tandis que recherche, enseignement et innovation enrichissent les connaissances et les pratiques.

23 · Définitions et mots-clés

Sigles et notions sont définis pour être employés en phrases entières, puis reliés à une situation. Les fonctions et les échelles permettent de distinguer les termes proches.

Terme	Définition
Santé publique	Approche de la santé à l'échelle des populations, associant connaissance de l'état de santé et actions collectives pour le préserver ou l'améliorer.
Système de santé	Ensemble organisé des acteurs, ressources, institutions et activités qui concourent à la santé ; il dépasse le seul système de soins.
Système de soins	Ensemble des services et interventions de prévention, de traitement, de réadaptation ou de soins palliatifs répondant aux besoins de santé.
Offre de soins	Professionnels, structures, équipements et services disponibles ou mobilisables pour répondre aux besoins de soins.
Accès aux soins	Possibilité effective d'obtenir des soins adaptés ; elle ne se déduit pas de la seule présence de professionnels sur une carte.
Équité	Recherche d'une réponse adaptée aux besoins, sans discrimination ; elle ne se réduit pas à une offre identique en apparence.
Continuité des soins	Cohérence du suivi dans le temps et entre intervenants, notamment lors des passages entre hôpital et ville.
Prévention	Interventions visant à éviter ou limiter des problèmes de santé et leurs conséquences, à l'échelle individuelle ou collective.
Réadaptation	Interventions visant la récupération ou l'adaptation après une maladie, un accident ou une intervention.
Soins palliatifs	Interventions orientées vers le soulagement et l'accompagnement de la personne ; une fonction distincte des seules interventions curatives.
Profession médicale	Catégorie regroupant, dans le cours, médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
Maïeutique	Terme associé à la profession de sage-femme.

Définitions et mots-clés - suite

Terme	Définition
Auxiliaire médical	Professionnel appartenant à l'ensemble des auxiliaires médicaux, dont les infirmiers ; cette catégorie ne décrit pas à elle seule les actes autorisés.
IDE	Infirmier diplômé d'État : professionnel participant aux soins, à la surveillance, à la prévention et à la continuité des prises en charge.
IPA	Infirmier en pratique avancée : forme d'exercice infirmier avec des compétences élargies dans un cadre défini ; ne signifie pas autorisation de tout acte.
Ordre professionnel	Organisme de régulation d'une profession, intervenant notamment sur le tableau, la déontologie et la discipline.
Tableau de l'Ordre	Registre des professionnels inscrits à l'ordre de la profession concernée.
Exercice salarié	Mode d'exercice dans le cadre d'un emploi, donnant lieu à un salaire.
Exercice libéral	Mode d'exercice indépendant, présenté notamment à travers la rémunération à l'acte dans le cours.
Exercice mixte	Association d'une activité salariée et d'une activité libérale pour un même professionnel.
DPC	Développement professionnel continu : démarche liée à l'actualisation des pratiques et à la formation professionnelle.
Effectif	Nombre de professionnels dans un périmètre donné, à distinguer d'une densité rapportée à la population.
Densité professionnelle	Nombre de professionnels rapporté à une population, selon l'unité et le champ de mesure retenus.
Projection	Scénario concernant une évolution future, construit à partir d'hypothèses ; ce n'est pas une observation déjà réalisée.
Établissement de santé	Organisation assurant notamment diagnostic, surveillance et traitement, avec des modalités de soins avec ou sans hébergement.
CH	Centre hospitalier : établissement hospitalier public cité parmi les types d'établissements de santé.
CHR	Centre hospitalier régional : catégorie d'établissement public figurant dans l'organisation hospitalière présentée.
CHU	Centre hospitalier universitaire : articulation des missions de soin, d'enseignement et de recherche.
ESPIC	Établissement de santé privé d'intérêt collectif : établissement privé à but non lucratif dans la présentation du cours.
MCO	Médecine, chirurgie, obstétrique : ensemble d'activités hospitalières à distinguer d'un statut juridique d'établissement.
SSR	Soins de suite et de réadaptation : appellation employée dans le support pour le secteur de récupération et de réadaptation.

Définitions et mots-clés - suite

Terme	Définition
USLD	Unité de soins de longue durée : prise en charge de personnes nécessitant une surveillance médicale importante et durable.
CLCC	Centre de lutte contre le cancer : exemple d'établissement spécialisé en cancérologie.
Médico-social	Domaine articulant soins, autonomie, accompagnement et besoins sociaux ou de vie quotidienne.
EHPAD	Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : structure médico-sociale associant hébergement, accompagnement et soins.
Soins de ville	Soins réalisés hors établissements de santé et structures médico-sociales, notamment au cabinet ou au domicile.
Hospitalisation conventionnelle	Prise en charge hospitalière comportant un hébergement et des nuitées dans l'établissement.
HDS	Hôpital de semaine : modalité d'organisation hospitalière sur la semaine.
HDJ	Hôpital de jour : venue pour examens ou traitements sans nuitée dans l'établissement.
Ambulatoire	Mode de prise en charge sans nuitée dans la structure, possible en ville comme à l'hôpital.
HAD	Hospitalisation à domicile : organisation hospitalière au domicile, distincte des seuls soins de ville à domicile.
Virage ambulatoire	Développement des prises en charge sans nuitée lorsque la situation s'y prête, avec organisation des relais et du suivi.
Soins programmés	Soins anticipés et planifiés, par exemple une consultation de suivi ou une intervention prévue.
Soins non programmés	Réponse à un besoin imprévu nécessitant une prise en charge rapide, distincte d'une urgence vitale.
SAS	Service d'accès aux soins : dispositif participant à la régulation et à l'orientation des demandes vers une réponse adaptée.
Régulation	Évaluation d'une demande et orientation vers une ressource adaptée au besoin et à son degré de priorité.
Premier recours	Soins de premier contact répondant aux besoins courants, à la prévention et au suivi de proximité.
Deuxième recours	Prise en charge spécialisée au-delà des ressources habituelles du premier recours, en ville ou à l'hôpital.
Soins tertiaires	Prises en charge complexes nécessitant une organisation, des équipes et des équipements spécialisés.
Soins quaternaires	Prises en charge particulièrement spécialisées ou inhabituelles, dont certaines procédures expérimentales dans le modèle présenté.

Définitions et mots-clés - suite

Terme	Définition
Parcours de soins coordonné	Organisation cohérente des consultations, examens, traitements et suivis autour du patient.
Médecin traitant	Médecin jouant un rôle central de suivi, de prévention, d'orientation et de coordination ; il peut être généraliste ou spécialiste.
ALD	Affection de longue durée : notion associée dans le cours au protocole de soins et au suivi coordonné.
Parcours de santé	Périmètre englobant le parcours de soins et les dimensions médico-sociales et sociales de la situation.
ESP	Équipe de soins primaires : professionnels du premier recours qui coordonnent leurs pratiques autour d'une population ou d'un projet.
CDS	Centre de santé : structure de soins regroupant des professionnels, généralement salariés dans les exemples du cours.
MSP	Maison de santé pluriprofessionnelle : organisation de soins reposant sur un projet pluriprofessionnel, généralement avec des libéraux dans le cours.
CPTS	Communauté professionnelle territoriale de santé : organisation de coordination des acteurs de santé d'un territoire.
DMP	Dossier médical partagé : outil numérique de partage d'informations utiles au suivi de la personne.
Mon espace santé	Espace numérique de santé du patient, présenté comme support de continuité et de circulation des informations utiles.
Déconcentration	Déploiement territorial d'un pilotage national ; repère à distinguer de la répartition décentralisée des compétences.
Décentralisation	Logique de répartition de compétences entre niveaux ou acteurs territoriaux, distincte du seul déploiement d'un pilotage national.
LFSS	Loi de financement de la Sécurité sociale : loi annuelle déterminant notamment le cadre et des objectifs financiers de la protection sociale.
ONDAM	Objectif national de dépenses d'Assurance maladie : objectif financier, à distinguer d'un organisme ou d'un remboursement individuel.
HPST	Loi Hôpital, patients, santé et territoires : repère de 2009 dans l'évolution de l'organisation sanitaire.
DGS	Direction générale de la santé : direction centrée sur les politiques et objectifs de santé publique.
DGOS	Direction générale de l'offre de soins : direction chargée du pilotage stratégique de l'offre de soins.
DSS	Direction de la Sécurité sociale : direction intervenant sur le cadre, les mesures et les objectifs financiers de la protection sociale.
DGCS	Direction générale de la cohésion sociale : direction intervenant notamment sur l'exclusion, les familles et l'autonomie.

Définitions et mots-clés - suite

Terme	Définition
DREES	Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques : production et analyse d'informations sanitaires et sociales.
IGAS	Inspection générale des affaires sociales : corps d'inspection figurant dans l'organisation ministérielle présentée.
ARS	Agence régionale de santé : acteur régional d'organisation de l'offre, du médico-social, de prévention et de sécurité sanitaire.
OMS	Organisation mondiale de la santé : organisation intervenant à l'échelle mondiale dans le domaine de la santé.
UNICEF	Fonds des Nations unies pour l'enfance : acteur international associé notamment à la santé et aux besoins de l'enfance.
RGPD	Règlement général sur la protection des données : cadre européen de protection des données personnelles, dont les données de santé.
HAS	Haute Autorité de santé : organisme d'expertise scientifique indépendant contribuant notamment à l'évaluation, aux bonnes pratiques et à la qualité.
Certification	Démarche d'évaluation des établissements de santé portant notamment sur la qualité et la sécurité des soins.
Qualité	Caractère correct de la réalisation et des conditions d'un soin ; à distinguer de son utilité dans une situation.
Pertinence	Adéquation et utilité d'un soin au regard des besoins de la personne et de la situation.
Efficience	Mise en relation des résultats obtenus avec les ressources mobilisées, sans se limiter au prix le plus bas.
Sécurité sociale	Système de protection sociale couvrant différents risques de la vie ; l'Assurance maladie en est une composante.
Assurance maladie	Composante de la protection sociale intervenant notamment dans la prise en charge des dépenses de santé et l'accompagnement des assurés.
CNAM	Caisse nationale de l'Assurance maladie : échelon national d'orientation et de pilotage du réseau.
CPAM	Caisse primaire d'Assurance maladie : organisme de mise en œuvre locale, de gestion des droits et des prestations prises en charge.
Maîtrise médicalisée	Recherche de gains d'efficience dans les dépenses de santé en conservant une logique médicale.
Reste à charge	Part d'une dépense restant après la prise en charge considérée ; préciser le niveau de prise en charge auquel on se réfère.
Complémentaire santé	Couverture pouvant prendre en charge tout ou partie de dépenses non couvertes par l'Assurance maladie, selon les conditions applicables.
Mutuelle	Type d'organisme à but non lucratif pouvant proposer une complémentaire santé ; toutes les complémentaires ne sont pas des mutuelles.

Définitions et mots-clés - suite

Terme	Définition
Surveillance sanitaire	Recueil et analyse d'informations permettant de suivre les maladies, l'état de santé et les risques sanitaires.
ECDC	Centre européen de prévention et de contrôle des maladies : agence européenne participant à la surveillance des maladies et épidémies.
Santé publique France	Agence nationale de santé publique intervenant dans la surveillance, la prévention, la promotion de la santé et la réponse aux menaces.
ANSES	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail : acteur d'expertise en sécurité sanitaire.
ANSM	Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé : acteur national de la sécurité des produits de santé.
EMA	Agence européenne des médicaments : acteur européen d'évaluation et de surveillance des médicaments.
EFS	Établissement français du sang : acteur de collecte, préparation, qualification et distribution des produits sanguins labiles.
Agence de la biomédecine	Organisme de référence dans les domaines biologiques et médicaux présentés, notamment les greffes.
Pharmacovigilance	Surveillance des effets et des risques liés aux médicaments.
Matériovigilance	Surveillance des risques liés aux dispositifs médicaux.
Hémovigilance	Surveillance liée à la chaîne transfusionnelle et aux produits sanguins concernés.
Biovigilance	Surveillance des activités et produits biologiques concernés, notamment dans le domaine des greffes.
INCa	Institut national du cancer : acteur d'expertise et d'action dans le domaine de la cancérologie cité parmi les organismes sanitaires.